先行研究調査課題レポート

早稲田大学 菊池研究室 感性班
北野玄

2026 年 9 月 30 日

第 1 章

1.1 動機・背景

大学生は、受験、就職活動、人間関係、恋愛などをめぐり、さまざまな嫌な体験をする。嫌な体験の多くは、生命の危険を伴わない。しかし、生命の危険を伴わない出来事でも、外傷後ストレス反応は生じうるとされる [1]。日本では、同様の出来事も「広義のトラウマ」として研究の対象とされてきた [1]。大学生を対象とした調査でも、外傷後ストレス反応の程度とレジリエンスとの関連が報告されている [2]。

嫌な体験を言語化する機会は、日常に数多く存在する。例えば、日記の執筆、SNS への投稿、友人への相談が挙げられる。心理学では、体験を物語として語る行為が、理論、臨床、実験の各面から研究されてきた。理論の面では、人間の思考には、論理・科学的な様式に加えて、物語的な様式があるとされる [3]。物語的な様式とは、出来事を意図と行為の時間的なつながりとして理解する思考様式である [3]。物語的な理解は、自己の理解にも及ぶ。人は、再構成した過去と想像した未来とを統合した自己の物語（ナラティブ・アイデンティティ）によって、人生にある程度のまとまりと目的を与えている [4]。

臨床の面では、物語療法（ナラティブ・セラピー）が提唱された [5]。物語療法は、問題に染まった支配的な物語を、本人が別の物語へと語り直す過程を支援する心理療法である [5]。実験の面では、ストレスフルな体験を書く行為が心身の健康に与える影響が、筆記開示（expressive writing）の研究として数多く検証されてきた [6, 7]。

しかし、体験を語れば必ず回復するとは限らない。筆記開示の効果は、平均すると小さい [7]。また、効果の大きさは条件によって異なる [7]。効果を左右する条件の一つとして、語り方、特にことばの使い方が考えられる。ことばの使い方は、語り手が自ら選択し、変更できる要素である。立ち直りを助けることばの使い方の知見は、嫌な体験を抱えた学生が自ら実践できる、語り方や書き方の指針となりうる。加えて、同じ知見は、語りを支援するシステムの設計にも活用しうる。さらに、語りのことばは計量的に分析できるため、本研究の問いは言語情報処理の観点からも意義をもつ。

1.2 GRQ・用語

以上の動機と背景に基づき、本研究の大まかな問い（General Research Question: GRQ）を次のように定める。

GRQ：青年期（大学生）の日本語話者が嫌な体験を物語として語るとき、どのようなことばの使い方が立ち直りを助けるのか

本研究では、GRQ に含まれる語を次の意味で用いる。

「嫌な体験」は、本人にとって否定的な感情を伴い、後に想起されて苦痛をもたらしうる出来事を指す。本研究では、「嫌な体験」を、臨床的な診断基準を満たす外傷体験に限定しない。

「物語として語る」とは、出来事を時間的な順序と因果関係に沿って言語化する行為を指す。本研究では、口頭での発話と文章での筆記の両方を「語る」に含める。

「立ち直り」は、先行研究 [8] の区別に従い、回復（recovery）の軌跡を指す。回復の軌跡では、出来事の後に、抑うつや心的外傷後ストレス障害（posttraumatic stress disorder: PTSD）の症状によって、通常の機能が一時的に損なわれる [8]。機能の低下は、多くの場合、少なくとも数か月続く。やがて、機能は徐々に出来事以前の水準へ戻る [8]。同研究は、回復を、出来事の後も比較的安定した健康な機能を保つレジリエンス（resilience）と区別した。

一方、日本では、レジリエンスは「精神的回復力」とも呼ばれる [9]。精神的回復力とは、困難な状況による一時的な心理的不健康を乗り越え、適応している状態を指す [9]。すなわち、日本語の「レジリエンス」は、先行研究 [8] のいう回復を含む意味で用いられる場合がある。本研究では、回復とレジリエンスとの混同を避けるため、「立ち直り（回復）」の語を用いる。

「ことばの使い方」は、語り方のうち、語られたことばに現れる側面を指す。本研究では、ことばの使い方を次の四つの層に分けて捉える。

（1）語：どの語を選ぶか。例えば、感情語や、洞察・因果を表す語の使用。

（2）視点：自己をどの位置から、どのように指して語るか。例えば、一人称で語るか、距離をとって語るかの違い。

（3）筋：出来事をどのように展開させ、締めくくるか。例えば、否定的な出来事が肯定的な結果に転じる展開。

（4）意味づけ：体験に理由、教訓、自己にとっての意味を見いだすか否か。

1.3 節では、四つの層に沿って先行研究を整理する。表 1.1 に、本研究で用いる主な用語と、対応する英語表現を示す。

表 1.1: 本研究で用いる主な用語

用語	英語表現	定義・本研究での用い方
立ち直り（回復）	recovery	出来事の後に通常の機能が一時的に損なわれ、徐々に出来事以前の水準へ戻る軌跡 [8]。本研究の GRQ における「立ち直り」を意味する。
レジリエンス	resilience	先行研究 [8] の用法では、出来事の後も比較的安定した健康な機能を保つ軌跡。日本では「精神的回復力」とも呼ばれ、一時的な心理的不健康を乗り越えて適応している状態を指す [9]
心的外傷後成長	posttraumatic growth (PTG)	困難との格闘の結果として生じる肯定的な心理的変容 [10]。
ナラティブ思考（物語的な思考様式）	narrative mode of thought	出来事を意図と行為の時間的なつながりとして理解する思考様式。論理・科学的な様式（paradigmatic mode）と対置される [3]
ナラティブ・アイデンティティ	narrative identity	再構成した過去と想像した未来とを統合し、人生にある程度のまとまりと目的を与える、内面化され変化し続ける自己の物語 [4]
物語療法	narrative therapy	問題に染まった支配的な物語を、本人が別の物語へと語り直す過程を支援する心理療法 [5]
物語に基づく介入	narrative-based intervention (NBI)	自伝的記憶を物語として再構成する過程を中核とする治療的介入 [11]
筆記開示（表現筆記）	expressive writing; written emotional disclosure	ストレスフルな体験の事実だけでなく、感情や思考を、短時間ずつ数日にわたって書く課題 [6]
構造化開示	structured disclosure	何をどのように書くかを実験者が詳しく指示する筆記開示 [1]
感情ラベリング	affect labeling	感情をことばで名指す行為。本人に調整の意図がなくても感情を弱めうる [12]
自己距離化	self-distancing	自分の体験を、没入した当事者の視点ではなく、一歩離れた観察者の視点から捉える心的操作 [13]。自分を名前や三人称で指すセルフトークによっても生じうる [14]
救済／汚染シークエンス	redemption / contamination sequence	否定的な場面が肯定的な結果へと転じる語りの展開／肯定的な場面が否定的な結果によって損なわれる展開 [15]
意味づけ	meaning-making	体験に理由、教訓、自己にとっての意味を見いだす行為（本研究での作業的な定義）
LIWC	Linguistic Inquiry and Word Count	語を心理的・言語的なカテゴリに分類した辞書を用い、文章中の各カテゴリの語の割合を数える分析法。日本語版に J-LIWC2015 がある [16]

1.3　先行研究

本節では、GRQ に関わる先行研究を次の順序で整理する。1.3.1 項では、嫌な体験を語る・書く行為の効果が小さく、一貫しない点を確認する。1.3.2 項では、効果が語り方によって異なる点と、語り方の違いが書かれたことばに現れる点を示す。1.3.3〜1.3.6 項では、ことばの使い方の四つの層ごとに知見を整理する。1.3.7 項では、日本語話者を対象とした研究の到達点を確認する。1.3.8 項では、日本語のことばの水準で検証が進んでいない理由を考察する。

1.3.1　語る・書く行為の効果と不安定さ

筆記開示の研究は、トラウマとなった体験を書く行為が健康に与える影響の検討から始まった [6]。以後、同様の実験が数多く行われてきた。無作為化を行った 146 の研究を統合したメタ分析では、心身の健康と全般的な機能に対する筆記開示の有意な効果が示された [7]。ただし、平均効果量は $r = .075$ と小さかった。加えて、効果の大きさは、複数の調整要因によって異なっていた。

日本でも、トラウマの筆記開示の効果が検討されてきた。先行研究 [1] では、大学生 25 名を三つの群に無作為に割り当てた。構造化開示群は、認知的再評価を促す詳細な指示に従って、トラウマを筆記した。自由開示群は、トラウマを自由に筆記した。統制群は、中性的な話題を筆記した。各群は、20〜30 分の筆記を 3 日間行った。実験の結果、両開示群で、内分泌系の改善効果が維持される可能性が示された。認知機能では、構造化開示群が統制群を上回る傾向がみられた（有意傾向）。同研究は、手続きを改訂した上で再検証する必要があると結論づけた。

臨床の領域では、自伝的記憶を物語として再構成する介入の有効性が、より明確に示されている。無作為化比較試験のメタ分析では、物語に基づく介入（narrative-based intervention: NBI）による PTSD 症状の低減が示された [11]。ただし、NBI は、PTSD の症状をもつ人々を対象とし、主に治療者が主導する介入である。したがって、NBI の知見は、非臨床の大学生が自ら嫌な体験を語る場面に直ちには一般化できない。

以上より、嫌な体験を語る・書く行為には、一定の効果が期待できる。しかし、語る行為が常に効果をもつとは限らない。次項では、効果を左右する要因として語り方に注目する。

1.3.2　効果を分ける語り方

同じ種類の出来事を書いても、書き方によって結果が異なる場合がある [17]。同研究では、大学生 122 名を三つの群に分け、1 か月間日記を書かせた。第一の群は、ストレスフルな体験またはトラウマとなった体験を、感情に焦点を当てて書いた。第二の群は、同様の体験を、感情と認知（考えや理解）の両方に焦点を当てて書いた。第三の群は、報道された出来事を事実的に書いた。比較の結果、第二の群では、体験の肯定的な側面への気づきが、他の 2 群より高まった。気づきの向上は、筆記中の認知的な処理によって媒介されていた。一方、第一の群では、病気の症状の報告が増加した。症状の増加は、否定的な感情表現への焦点化によって媒介されていた。同研究の知見は、

感情の表出に加えて、体験を理解しようとする書き方が、筆記の効果を左右する可能性を示唆している。

書き方の違いは、実際に書かれた文章の語の使い方としても観察できる。先行研究 [18] では、過去の筆記研究に参加した 177 名の文章を対象に、カテゴリごとに語の出現頻度を計数した。分析の結果、洞察や因果を表す語（英語の think, know, because など）の使用が筆記の過程で増加した参加者ほど、身体的な健康が改善していた。精神的な健康との関連は、認められなかった。また、否定的な感情語に比べて肯定的な感情語を多く用いた参加者ほど、健康状態が良好であった。別の先行研究 [19] では、三つの筆記開示研究のデータを、潜在意味解析によって再分析した。再分析の結果、人称代名詞をはじめとする機能語の使い方が筆記の回ごとに大きく変化した参加者ほど、筆記後の健康が改善していた。

先行研究 [18, 19] の結果は、語り方の違いを語の水準で捉えられる可能性を示唆している。語の水準の違いは、健康の指標とも関連していた。ただし、両研究は、いずれも既存データの相関的な分析である。したがって、語の使い方を意図的に変えた場合に効果が生じるかは、別途検証する必要がある。加えて、先行研究 [17–19] の知見は、いずれも英語で書かれた文章から得られている。

1.3.3 ことばの使い方：語

語の層では、感情語の研究が多く行われてきた。感情をことばで名指す行為は、感情ラベリング（affect labeling）と呼ばれる。感情ラベリングの研究を概観したレビュー [12] によれば、感情ラベリングは、本人に感情を調整する意図がなくても感情経験を弱める。感情ラベリングの効果は、主観的な体験、自律神経系の反応、神経活動、行動の各側面で認められる。効果のパターンは、意図的な調整方略である再評価と類似している。同レビューは、各側面での効果に基づき、感情ラベリングを潜在的な感情調整の一形態と位置づけた。

同レビューは、未解決の問題も挙げた。第一に、作用機序の解明は初期段階にある。第二に、ラベルの与え方によって、効果の時間経過が異なる。提示された選択肢からラベルを選ぶ研究では、効果は即時に現れる。他方、自らことばを生成する研究では、効果が遅れて現れる。生成の直後には、むしろ否定的な感情が強まる場合もある。第三に、用いる感情語の量と効果との関係は一貫していない。多いほど良いとする結果と、多すぎると効果が低下する曲線的な関係を示す結果とが並存している。先行研究 [18] の知見も合わせると、感情語の効果は使用量に比例するとは限らない。すなわち、どの感情語を、どの程度、どの時点で用いるかによって、効果が異なる可能性がある。

1.3.4 ことばの使い方：視点

語りの視点に関わる知見として、自己距離化（self-distancing）の研究がある。先行研究 [13] では、参加者に、怒りを感じた体験を想起させた。一方の条件の参加者は、場面に入り込んで体験を追体験するよう教示された。他方の条件の参加者は、場面から一歩離れ、遠くにいる自分を眺めるように想起するよう教示された。また、感情の内容を思い出す条件と、感情の理由を考える条件と

が設けられた。実験の結果、距離をとった視点で感情の理由を考えた群では、怒りや否定的な感情が再燃しにくかった。同研究の結果は、距離をとった内省が、否定的な感情を強める反すうとは区別されうると示唆している。ただし、同研究では、距離化をイメージの教示によって操作した。ことばの使い方は、操作の対象とされていない。

ことばの水準での距離化は、先行研究 [14] で検討された。同研究では、自分に語りかける際の自己の指し方を操作した。ストレス場面には、第一印象を与える場面や人前でのスピーチが用いられた。実験の結果、一人称（I）ではなく自分の名前や三人称で自分を指した場合に、ストレス場面での苦痛が小さかった。遂行の評価も良好であった。他方、筆記開示の人称を操作した先行研究 [20] では、一人称で書いた場合の主観的な恩恵が最も大きかった。一人称の筆記では、認知的な処理を表す語も多く用いられていた。したがって、距離をとる語り方が常に有利とは限らない。どの視点が助けとなるかは、課題や状況によって異なる可能性がある。なお、先行研究 [19] は、特定の視点ではなく、視点の切り替え（代名詞の使い方の柔軟性）を健康と関連づけた。

日本語話者を対象とした研究でも、非一人称のセルフトークの効果が検討され始めている。先行研究 [21] では、大学生 72 名が、一人称または非一人称のセルフトークを行いながら、自己制御課題（ハンドグリップを握り続ける課題）に取り組んだ。実験の結果、一人称と非一人称の効果の差は、促進焦点（利得や理想の達成に注意を向ける動機づけの状態）を活性化した条件でのみ認められた。先行研究 [22] では、スピーチ不安を扱う面接で、一人称を使わずに自分を指すよう参加者に求めた。分析の結果、自己距離化の程度にも不安の程度にも、条件間で有意な差は認められなかった。以上のように、日本語での結果は一貫していない。加えて、先行研究 [21, 22] が扱ったのは、課題遂行中の自己制御と、予定されたスピーチへの不安である。日本語話者が過去の嫌な体験を語る場面での自己の指し方を扱った研究は、本調査の範囲では見当たらなかった。

1.3.5 ことばの使い方：筋

体験の展開を扱った代表的な知見として、救済シークエンスと汚染シークエンスの研究がある [15]。救済シークエンスは、否定的な場面が肯定的な結果へと転じる展開である。汚染シークエンスは、肯定的な場面が否定的な結果によって損なわれる展開である。同研究では、中年期の成人と大学生が、人生の最高点、最低点、転機などの場面を語った。中年期の成人は口頭の面接で語り、大学生は筆記で語った。語りを評定した結果、両方の標本で、救済シークエンスが心理的な幸福感と正に関連した。中年期の成人では、汚染シークエンスが幸福感の低さを予測した。さらに、救済シークエンスは、語り全体の感情的なトーンよりも強く幸福感を予測した。ただし、同研究は相関研究である。したがって、救済的な語りが幸福感を高めるのか、幸福な人が救済的に語るのか、因果の向きは特定できない。

先行研究 [23] は、日本語話者を対象に、語りの展開を操作した。同研究では、大学生 21 名が、否定的な体験である大学受験の準備を「楽しかった」体験として語り直した。対照群の大学生 23 名は、同じ体験を事実どおりに語り直した。次に、両群が元の体験を想起した。実験の結果、語り直し群の想起では、対照群に比べて肯定的な感情語が増え、否定的な感情語が減っていた。体験に

関わる概念の感情価も、肯定的な方向へ変化していた。同研究の結果は、肯定的な語り直しによって自伝的記憶自体が変容しうると示唆している。ただし、同研究が測定したのは、想起と概念の感情価の変化である。想起の変化と、気分や適応といった立ち直りの指標との関係は、検討されていない。また、同研究の語り直しは、教示によって方向づけられていた。自発的な語りでも同様の変化が生じるかは明らかでない。

救済の筋と幸福感との関連は、文化によって異なる可能性もある。先行研究 [24] では、米国、日本、イスラエル、デンマークの成人 438 名が、人生の最低点と困難を筆記した。日本の参加者は 122 名であった。参加者は、心理的な幸福感の自己報告尺度にも回答した。分析の結果、米国とイスラエルでは、救済が幸福感と正に関連した。一方、日本とデンマークでは、救済と幸福感との関連は弱いか、認められなかった。日本では、汚染も幸福感と有意に関連しなかった。日本の語りには、困難をありのままに受け入れる「受容」、誰に非があったかを述べる「非難の帰属」、未解決のまま終わる語りなどの特徴がみられた。したがって、救済の筋を望ましい語り方とみなす米国中心の知見は、日本語話者に直ちに当てはまるとは限らない。なお、同研究は、語りの展開や主題を評定・分類した。日本語の言語形式自体は分析の対象とされていない。

日本語の自己語りを対象として、語りの構造的な整合性・一貫性と自我同一性との関連を、高齢者で検討した研究もある [25]。ただし、同研究は、嫌な体験からの立ち直りを扱っていない。

1.3.6　ことばの使い方：意味づけ

体験に理由や意味を見いだす行為の重要性は、1.3.2 項で述べた知見 [17,18] にも表れている。日本では、怒りを対象とした構造化筆記の効果が検討された [26]。同研究では、大学生 55 名が、怒りを感じた過去の出来事を筆記した。構造化筆記条件の参加者は、状況を捉え直し、新たな意味を見いだすよう教示された。実験の結果、同条件の参加者では、他の条件の参加者に比べて、怒りの持続が弱まった。怒りの持続を規定する「思考の未統合感」も低下した。さらに、同条件の参加者には、実験後に怒りの出来事を他者に話す傾向がみられた。他者に話す際には、否定的な言動が減少し、話し方が変化する傾向にあった。以上の結果は、意味づけを促す筆記が、後の語り方にも影響する可能性を示唆している。

臨床の領域でも、メタ分析 [11] は、NBI の効果の背景に、記憶の物語的な統合と意味づけを想定した。ただし、NBI が恐怖以外の感情（恥、罪悪感、怒りなど）にも対処できるかは、今後の課題とされた。加えて、意味づけの研究で測定されてきた指標は、体験の肯定的な側面への気づき [17] や怒りの持続 [26] など、立ち直りの一側面に限られる。立ち直りを時間的な軌跡として捉えた検討は、本調査の範囲では少なかった。

1.3.7　日本語話者を対象とした研究

本項では、日本語話者を対象とした研究を、ことばの扱い方の観点から四つに分けて整理する。

第一に、書き方を教示で操作し、効果を心身の指標で測定する研究がある。構造化開示の研究 [1]

は、共通の研究者を含むグループによって継続されている [27–29]。例えば、出来事からの距離化を促す構造化筆記の効果が検討された [27]。外傷後ストレス反応が持続している個人の筆記内容を検討した研究もある [28]。怒りを対象とした構造化筆記の研究 [26] も、第一の区分に含まれる。

第二に、語られたことばや語り方の変化を測定した研究がある。先行研究 [23] は、語り直し後の想起で生じた感情語の増減を報告した。先行研究 [26] は、実験後の他者への語りで生じた否定的な言動の減少を報告した。先行研究 [29] は、構造化開示に「想定書簡法」を加えた。想定書簡法は、自分の気持ちを理解する他者を想定して手紙を書く手続きである。同研究は、各群 6〜7 名の小規模な実験で、筆記内容と心身の機能との関連も探索的に検討した。検討の結果、構造化開示群では、自由開示群よりも距離化の程度が高い傾向がみられた。しかし、心身の機能の改善に、群間で有意な差は認められなかった。なお、構造化開示群では、洞察を表す語の増加が身体的な健康の改善と関連する可能性が示唆された。

第三に、語りの展開や主題を評定した研究がある。日本を含む 4 か国の比較文化研究 [24] が、第三の区分に該当する。

第四に、語りのことば自体は分析しない研究がある。例えば、レジリエンスや体験の開示と外傷後ストレス反応との関連を調べた質問紙調査 [2] が該当する。非一人称のセルフトークの効果を調べた実験 [21, 22] も、第四の区分に含まれる。

以上のように、日本語話者を対象とした研究でも、書き方の操作、一部の語の計数、主題の評定は行われてきた。しかし、計数された語は、感情語や洞察を表す語など、英語圏の研究でも用いられてきたカテゴリにとどまる。また、語の計数には、少人数の探索的な検討も含まれる。日本語に特有の言語形式と立ち直りとの関係を扱った研究は、本調査の範囲では見当たらなかった。日本語に特有の言語形式の例として、文中での自己の指し方（自己を明示しない場合を含む）や、感情を誰のものとしてどのように述べるかが挙げられる。

1.3.8 日本語で検証が進んでいない理由

日本語の語りのことばと立ち直りとの関係が体系的に検討されてこなかった理由として、次の三つが考えられる。ただし、いずれの理由も、本調査の範囲で得た手がかりに基づく推測を含む。

第一に、分析の道具の問題がある。英語圏では、LIWC が標準的な道具として用いられてきた [16]。LIWC は、語を心理的・言語的なカテゴリに分類した辞書に基づき、文章を計量する。筆記開示の研究でも、LIWC を用いた語の分析が行われてきた [18]。しかし、日本語版の辞書である J-LIWC2015 の開発論文は、2022 年に発表された [16]。同論文は、J-LIWC2015 以前には標準化された日本語版 LIWC 辞書が研究者に提供されていなかったと述べた。英語の辞書を日本語に移す作業の困難さも指摘した。したがって、日本語の語りを計量する標準的な手段が最近まで整っていなかった点が、一因と考えられる。

第二に、言語の構造の違いがある。英語圏では、自己の指し方が視点や距離化の指標とされてきた [14, 19, 20]。具体的には、一人称代名詞を用いるか、自分の名前や三人称を用いるかの違いである。しかし、日本語では主語がしばしば省略される。また、日本語では、自己を指す語（自称詞）

が相手や場面に応じて使い分けられる [30]。例えば、「私」「僕」「自分」、あるいは自分の名前が用いられる。さらに、日本語の感情形容詞には人称制限がある [31]。例えば、「私は悲しい」は自然であるが、「彼は悲しい」は不自然である。第三者の感情は、通常、「悲しそうだ」「悲しいらしい」のように、推量や伝聞の形で述べられる。したがって、英語の代名詞に基づく指標は、日本語に直ちには移せない。日本語では、自己からの距離が、代名詞以外の文法的な手段によって表現されている可能性がある。なお、以上は言語学的な知見に基づく推論であり、実証的には確かめられていない。

第三に、研究領域の分断がある。関連する知見は、異なる領域で蓄積されてきた。構造化開示は、臨床心理学や健康心理学で研究されてきた。救済の筋は、パーソナリティ心理学で扱われてきた。距離化や感情ラベリングは、実験的な感情研究の対象であった。語の計量は、計算言語学や計算社会科学で発展してきた。各領域の間では、共通の指標がほとんど用いられていない可能性がある。領域の分断の結果、日本語の語りのことばを、時間的な変化としての立ち直りと結びつけて分析する研究は、生まれにくかったと考えられる。

1.4 SRQ

本章の執筆時点では、具体的な問い（Specific Research Question: SRQ）は未確定である。本節では、GRQ に対して、先行研究で明らかになっている点と明らかになっていない点を整理する。また、SRQ を定める手がかりとして、未踏領域を示す。

GRQ：青年期（大学生）の日本語話者が嫌な体験を物語として語るとき、どのようなことばの使い方が立ち直りを助けるのか

1.4.1 先行研究で明らかになっている点

- 嫌な体験を語る・書く行為は、心身の健康に有意な効果をもつ [7]。ただし、効果は小さい [7]。また、効果の大きさは条件によって異なる [1, 7]。
- 効果は、語る内容だけでなく、語り方によっても異なる [17]。語り方の違いは、書かれた文章の語の使い方に現れる [18, 19]。語の使い方は、健康の指標とも関連する [18, 19]。
- 英語圏の研究では、語、視点、筋、意味づけの各層で、立ち直りや幸福感に関わりうることばの使い方が示されている [12–15, 17]。
- 日本語話者を対象とした研究でも、書き方の教示の効果、語り直しによる感情語の変化、構造化開示での洞察を表す語と健康との関連（探索的）などが報告されている [1, 23, 26, 29]。

1.4.2 明らかになっていない点（未踏領域）

以上の整理から、次の点が明らかになっていない。

日本語話者を対象に、書き方の教示の操作、語りの主題の評定、一部の語の探索的な計数は行われてきた。しかし、日本語の語りに現れる言語形式自体と、嫌な体験からの立ち直りとの関係は、体系的に検討されていない。対象となる言語形式には、自己の指し方、感情の述べ方、体験の締めくくり方などが含まれる。

未踏領域は、ことばの使い方の四つの層に沿って、次のように具体化できる。

（1）語：日本語の語りでは、洞察を表す語と健康との関連が、少人数の探索的な実験で示唆されたにとどまる [29]。感情語の変化は報告されている [23]。しかし、感情語の変化と立ち直りとの関係は、検討されていない。また、感情語の量や使用の時点が効果に与える影響は、英語圏でも未解決である [12]。

（2）視点：英語圏の代名詞に基づく距離化の指標は、日本語に直ちには移せない。日本語には、主語の省略、自称詞の使い分け、感情形容詞の人称制限があるためである。日本語の語りで距離化や没入に相当する言語形式は、特定されていない。距離化や没入の言語形式と立ち直りとの関係も、明らかになっていない。

（3）筋：救済の筋と幸福感との関連は、日本の成人では弱いか、認められない [24]。日本語話者の青年で立ち直りと関係する展開や締めくくり方は、明らかになっていない。例えば、日本の語りにみられた「受容」[24] と立ち直りとの関係は、検討されていない。

（4）意味づけ：意味づけを促す筆記の効果は、日本語話者でも示されている [26]。しかし、意味づけが日本語の語りのどのような表現に現れるかは、洞察を表す語の探索的な検討 [29] を除いて、明らかになっていない。意味づけの表現と立ち直りとの関係も、検討されていない。

さらに、いずれの層でも、立ち直りを時間的な軌跡（1.2 項）として追跡した検討は、本調査の範囲では少なかった。

1.4.3　今後の進め方

SRQ の確定に先立ち、未踏領域の主張を支える文献（特に文献 [24, 28, 29]）を精読し、内容を確認する必要がある。SRQ の設定では、次の二点が検討課題となる。第一に、参加者に嫌な体験を想起・言語化させる際の倫理的な配慮である。第二に、扱う体験の領域の限定である。

引用文献

[1] 伊藤大輔, 佐藤健二, 鈴木伸一. トラウマの開示が心身の健康に及ぼす影響ー構造化開示群，自由開示群，統制群の比較ー. 行動療法研究. 2009;35(1):1–12.

[2] 早川実桜, 伊藤大輔, 石橋正浩. 大学生における外傷性ストレス反応の関連要因の検討ーレジリエンスと体験の開示に着目してー. 発達心理臨床研究. 2023;29:71–79.

[3] Bruner J. Actual minds, possible worlds. Cambridge (MA): Harvard University Press; 1986.

[4] McAdams DP, McLean KC. Narrative identity. Current Directions in Psychological Science. 2013;22(3):233–238.

[5] White M, Epston D. Narrative means to therapeutic ends. New York: W. W. Norton; 1990.

[6] Pennebaker JW, Beall SK. Confronting a traumatic event: toward an understanding of inhibition and disease. Journal of Abnormal Psychology. 1986;95(3):274–281.

[7] Frattaroli J. Experimental disclosure and its moderators: a meta-analysis. Psychological Bulletin. 2006;132(6):823–865.

[8] Bonanno GA. Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? American Psychologist. 2004;59(1):20–28.

[9] 小塩真司, 中谷素之, 金子一史, 長峰伸治. ネガティブな出来事からの立ち直りを導く心理的特性ー精神的回復力尺度の作成ー. カウンセリング研究. 2002;35:57–65.

[10] Tedeschi RG, Calhoun LG. Posttraumatic growth: conceptual foundations and empirical evidence. Psychological Inquiry. 2004;15(1):1–18.

[11] Raeder R, Clayton NS, Boeckle M. Narrative-based autobiographical memory interventions for PTSD: a meta-analysis of randomized controlled trials. Frontiers in Psychology. 2023;14:1215225.

[12] Torre JB, Lieberman MD. Putting feelings into words: affect labeling as implicit emotion regulation. Emotion Review. 2018;10(2):116–124.

[13] Kross E, Ayduk O, Mischel W. When asking “why” does not hurt: distinguishing rumination from reflective processing of negative emotions. Psychological Science.

2005;16(9):709–715.

[14] Kross E, Bruehlman-Senecal E, Park J, Burson A, Dougherty A, Shablack H, et al. Self-talk as a regulatory mechanism: how you do it matters. Journal of Personality and Social Psychology. 2014;106(2):304–324.

[15] McAdams DP, Reynolds J, Lewis M, Patten AH, Bowman PJ. When bad things turn good and good things turn bad: sequences of redemption and contamination in life narrative and their relation to psychosocial adaptation in midlife adults and in students. Personality and Social Psychology Bulletin. 2001;27(4):474–485.

[16] Igarashi T, Okuda S, Sasahara K. Development of the Japanese version of the Linguistic Inquiry and Word Count dictionary 2015. Frontiers in Psychology. 2022;13:841534.

[17] Ullrich PM, Lutgendorf SK. Journaling about stressful events: effects of cognitive processing and emotional expression. Annals of Behavioral Medicine. 2002;24(3):244–250.

[18] Pennebaker JW, Mayne TJ, Francis ME. Linguistic predictors of adaptive bereavement. Journal of Personality and Social Psychology. 1997;72(4):863–871.

[19] Campbell RS, Pennebaker JW. The secret life of pronouns: flexibility in writing style and physical health. Psychological Science. 2003;14(1):60–65.

[20] Seih YT, Chung CK, Pennebaker JW. Experimental manipulations of perspective taking and perspective switching in expressive writing. Cognition and Emotion. 2011;25(5):926–938.

[21] 清水登大, 長峯聖人, 外山美樹. 非 1 人称セルフトークが自己制御に及ぼす影響―制御焦点を調整変数として―. 教育心理学研究. 2021;69(3):229–240.

[22] 稲井健太, 高橋史. 一人称を使用しない面接による Self-distancing 促進効果. 信州心理臨床紀要. 2023;22:13–24.

[23] 池田和浩, 仁平義明. ネガティブな体験の肯定的な語り直しによる自伝的記憶の変容. 心理学研究. 2009;79(6):481–489.

[24] Turner AF, Thomsen DK, Tuval-Mashiach R, Sevilla-Liu A, Cowan HR, Sumner S, et al. Narrative identity in context: how adults in Japan, Denmark, Israel, and the United States narrate difficult life events. Journal of Personality and Social Psychology. 2024;127(6):1263–1287.

[25] 野村晴夫. 高齢者の自己語りと自我同一性との関連―語りの構造的整合・一貫性に着目して―. 教育心理学研究. 2002;50(3):355–366.

[26] 遠藤寛子, 湯川進太郎. 怒りの維持過程に基づいた筆記開示法の検討―思考の未統合感に着目して―. カウンセリング研究. 2018;51(2):81–93.

[27] 松田郁緒, 湯浅明李, 矢代里緒, 塩田翔一, 小口美佳, 佐藤健二. トラウマに関連する反すうと侵入思考の関連および出来事からの距離化を促進するよう構造化された筆記の効果の検討. 徳島大学人間科学研究. 2015;23:19–38.

[28] 湯浅明李, 佐藤健二. トラウマの構造化開示が心身の機能に及ぼす影響―外傷後ストレス反応

を維持させている個人とその筆記内容の検討一. 徳島大学人間科学研究. 2016;24:29–48.
[29] 坂本和歌子, 佐藤健二. トラウマの構造化筆記開示が心身の機能に及ぼす影響一想定書簡法の手続きの追加と筆記内容の検討一. 徳島大学人間科学研究. 2018;26:12–31.
[30] 鈴木孝夫. ことばと文化. 東京: 岩波書店; 1973.
[31] 金水敏. 「報告」についての覚書. 仁田義雄, 益岡隆志 編. 日本語のモダリティ. 東京: くろしお出版; 1989. p.121–129.

付録 A

文献リスト

本調査で収集した文献のうち、本文で引用していない文献の書誌情報を示す。和文は第一著者の五十音順、欧文はアルファベット順に並べる。

伊藤大輔, 佐藤健二, 鈴木伸一. トラウマの構造化開示が気分状態，覚醒水準および主観的健康に及ぼす影響. 早稲田大学臨床心理学研究. 2009;8:89–97.

伊藤大輔, 鈴木伸一. トラウマ体験の致死性の有無が外傷後ストレス反応および外傷体験後の認知に及ぼす影響. 行動療法研究. 2009;35(1):13–22.

遠藤寛子. 怒りの維持と他者への共感―言語化による新たな視点の獲得―. エモーション・スタディーズ. 2015;1(1):3–8.

久楽貴恵, 田邉絵理子, 松田郁緒, 小口美佳, 佐藤健二. トラウマの構造化開示が心身機能に及ぼす影響―外傷後成長の検討―. 徳島大学人間科学研究. 2014;22:21–39.

佐藤健二. トラウマティック・ストレスと自己開示. ストレス科学. 2005;19:189–198.

佐藤健二. トラウマ筆記開示が心身の健康・高次認知機能に及ぼす影響. ストレス科学. 2014;29:55–67.

塚原貴子, 矢野香代, 新山悦子, 太田茂. 大学生における外傷体験の筆記による開示効果―心理的・身体的指標による分析―. 川崎医療福祉学会誌. 2010;20(1):235–242.

中川智香子, 佐藤健二. トラウマの構造化開示が外傷後ストレス反応とワーキング・メモリ容量に及ぼす影響. 人間科学研究（徳島大学総合科学部紀要）. 2008;16:93–106.

中野収太, 久楽貴恵, 吉田真由子, 佐藤健二. トラウマの構造化開示が外傷後ストレス反応とワーキング・メモリ容量に及ぼす影響―外傷後ストレス障害の認知モデルに基づく検討―. 人間科学研究（徳島大学総合科学部紀要）. 2012;20:31–48.

平野真理. レジリエンスの資質的要因・獲得的要因の分類の試み―二次元レジリエンス要因尺度（BRS）の作成―. パーソナリティ研究. 2010;19(2):94–106.

増田愛梨, 佐々木三紗, 桂川泰典. ライフイベントに関連した心理的苦悩へのセルフ・コンパッショ

ンを取り入れたロールレタリングの効果. 人間科学研究（早稲田大学）. 2025;38(2):177–186.

松原真紀, 戸田弘二. 構造化筆記開示はセルフ・コンパッションを高めるか？ 北海道心理学研究. 2024;47:9.

吉田真由子, 長谷川千詠, 松田郁緒, 久楽貴恵, 佐藤健二. トラウマ体験の有無とその構造化開示が心身機能に及ぼす影響. 徳島大学人間科学研究. 2013;21:61–80.

Kircanski K, Lieberman MD, Craske MG. Feelings into words: contributions of language to exposure therapy. Psychological Science. 2012;23(10):1086–1091.

McAdams DP. The redemptive self: stories Americans live by. New York: Oxford University Press; 2006.

Pennebaker JW. Writing about emotional experiences as a therapeutic process. Psychological Science. 1997;8(3):162–166.